

населения. Связь между вирусами папилломы человека высокого онкогенного риска (ВПЧ ВР) и РШМ, особенно с преинвазивными и инвазивными формами хорошо установлена. Исследования показали, что персистирующая инфекция ВПЧ ВР является самым важным фактором риска развития инвазивного РШМ. К сожалению, на сегодняшний день ничего не известно о распространенности ВПЧ ВР, имеющих наибольшее значение в развитии инвазивного рака шейки матки в Республике Казахстан. Следовательно, **целью нашего исследования** было оценить распределение типов ВПЧ ВР в биопсионном материале, полученных от казахстанских женщин с установленным диагнозом РШМ.

Методы: в исследование были включены 99 формалин фиксированных парафин содержащих (FFPE) образцов ткани с раком шейки матки, собранных в центре морфологических исследований Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Архивный материал, разрезанный в отделении Патологии Люблянского Университета толщиной до 10 µm, подвергался экстракции ДНК с использованием DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) по протоколу Института микробиологии и иммунологии медицинского факультета Люблянского университета. Обнаружение ВПЧ ВР проводилось с использованием RealTime High Risk HPV Test (Abbott,

Wiesbaden, Germany), который позволяет одновременно проводить генотипирование на ВПЧ 16 и 18 и 12 других типов: ВПЧ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68.

Результаты: Из 99 образцов два (2,0%) были исключены из исследования из-за неверных результатов амплификации с бета-глобином. В общей сложности 77/97 (79,4%) образцов имели положительный результат на наличие ВПЧ ВР. ВПЧ 16, ВПЧ 18 и другие типы ВПЧ ВР были обнаружены в 69/77 случаев (89,6%), 3/77 (3,9%) и 6/77 (7,8%) соответственно. В большинстве образцов (98,7%) была обнаружена моно инфекция с одним типом ВПЧ ВР.

Выводы. На сегодняшний день это первое исследование по оценке распределения типов ВПЧ ВР среди казахстанских женщин с РШМ. Распространенность ВПЧ ВР в опухолях шейки матки (FFPE) была несколько ниже по сравнению с аналогичными исследованиями в других странах, скорее всего, из-за процесса фиксации и/или условий хранения архивных материалов. Однако приблизительно 80% образцов имели положительный результат на наличие ВПЧ ВР, из которых ВПЧ16 был обнаружен почти в 90% случаев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что внедрение вакцинации против ВПЧ может оказать огромное влияние на заболеваемость раком шейки матки в Казахстане.

D. KAIDAROVA, ZH.CHINGISOVA, O.SHATKOVSKAYA, G SEYSENBAYEVA, S.ISMAILOV

Kazakh Research Institute of oncology and radiology, Almaty, the Republic of Kazakhstan

DYNAMICS OF DISEASE RATE OF ONCOGYNAECOLOGIC PATHOLOGY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR 10 YEARS (2007-2016)

Timeliness. Malignant tumors (MT) of cervix uteri, corpus uteri and ootheca are inside the top ten among all women oncopathology in disease distribution among women. According to world data (GLOBOCAN 2012), cervical cancer is 7,9% and takes 4th rank place in disease distribution among women, uterine corpus cancer – 4,8% and ovarian cancer – 3,6% (6 and 7 rank places accordingly). Cervical cancer, uterine corpus cancer and ovarian cancer took rank places from 3 to 5 in distribution of MT among women in 2016 in the Republic of Kazakhstan and were 9,1%, 5,9% and 5,6% accordingly among all women oncopathology.

Purpose. Analysis of dynamics of cervical cancer, uterine corpus cancer and ovarian cancer rates.

Materials and methods. Main medical report and account forms (Ф. №7, №35, №090/У) and database of cancer-register on malignant tumors (MT) and cervical cancer (CC), uterine corpus cancer (UCC) and ovarian cancer (OC) for 2007-2016, information about population size were used. Extensive (EI), intensive (II) and standardized (SI) indicators were calculated.

Results. Dynamic of disease incidence of three main nosology of malignant tumors of female reproductive organs for 10 years tends to increase. However,

er trends of disease incidence are slightly different by present pathologies.

Adjusted incidence rate with cervical cancer in the RK tends to growth since 2007 till 2015 from 13,51 to 17,56‰ and to reduction to 16,2‰ in 2016. Rate of increase of disease incidence in the Republic for the last 10 years was 20,8%. Disease incidence with CC has reduced on 1,34 ‰ or 7,6% in 2016 in comparison with 2015. Maximum increase was observed in 2012 (1,44‰). Minimum increase was fixed in 2016 (-1,34‰).

Average value of disease incidence with CC was 15,46‰ since 2007 till 2016. Rate of increase of analyzed indicator was 1,02 during the whole period. Disease incidence with CC has increased annually on 2,1% (on 0,3 ‰) in average. Stable linear increase of trend of disease incidence with cervical cancer was obtained during analytical equation of trend of disease incidence with trend rate 0,454 ($t > 2.306$).

Disease incidence with uterine corpus cancer in the RoK tends to increase during 10 years period. UCC disease incidence in the RK has increased on 1,19 ‰ or on 12,6% in 2016 (10,66‰) in comparison with 2007 (9,47‰). Average value of UCC disease incidence was 10,14‰ since till 2016. In average UCC disease incidence in the RK has increased in each period on 0,13 ‰ or on 1,3%. Maximum growth is observed in 2012 (0,9‰), minimum - in 2016 (-0,68‰). Disease incidence of UCC has reduced on 0,68‰ or on 6% in 2016 in comparison

with 2015. Rate of increase demonstrates that trend is decreasing and this is evidenced by deceleration of disease incidence of this pathology. However trend line is increasing and straight, with trend coefficient 0,22 ($t > 2,306$).

Indicators of incidence rates of ovarian cancer have periods of growth and reduction during 10 years, however, growth of disease incidence of this pathology is observed. Disease incidence of OC in the RoK has increased on 0,29‰ or on 3,2% in 2016 (9,42‰) in comparison with 2007 (9,13‰). Disease incidence of OC has increased in average on 0,03‰ (on 0,4%). Disease incidence of OC has reduced on 1,32‰ or on 12,3% in 2016 in comparison with 2015. Minimum increase was in 2016 (-1,32‰).

Growing rates demonstrate that trend is increasing and this is evidenced by acceleration of OC in the RoK (Trend rate $b = 0,123$, $t > 2.306$).

Conclusion. So, analysis of disease incidence for the last 10 years of main clinical entity of oncogynaecologic pathology demonstrates growth of present indicator. Growth rates in case of cervical cancer are the most expressed, then in case of uterine corpus cancer and then in case of ovarian cancer. Expressed increase of cervical cancer rate demonstrates necessity in performance of screening for detection of pre-tumor pathology and earlier forms of malignant tumors of cervix uteri with the purpose of increase of patients' life.

Н.П. ЦИП

Национальный институт рака, г. Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ИНИЦИИРОВАННЫХ ПУЗЫРНЫМ ЗАНОСОМ, У ПОДРОСТКОВ

Трофобластическая болезнь беременности это редкое заболевание, диагностируемое преимущественно у женщин детородного возраста.

Цель настоящего исследования – изучить особенности клиники и диагностики злокачественных трофобластических опухолей (ЗТО), инициированных пузырным заносом (ПЗ), у подростков.

Материалы и методы. Обследованы и пролечены 158 женщин злокачественными трофобластическими опухолями, инициированными пузырным заносом, получавшие специальное лечение

в отделении онкогинекологии Национального института рака (НИР). Основную группу составили 28 (17,7%) женщин подросткового возраста, контрольную – 130 (82,3%) женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

По определению ВОЗ подростковый возраст это период с 10 до 19 лет, в проведенном исследовании возраст больных подростковой группы колебался от 16 до 19 лет и составил в среднем $17,8 \pm 1$ лет. Средний возраст больных контрольной группы – $26,7 \pm 5$ лет. Большинство больных контрольной группы (66,9%) были в возрасте 20-27 лет.